

Traumatisme crânien léger de l'adulte

Introduction, méthodologie



Champ : patients adultes pris en charge en structure de médecine d'urgence dans les 24 heures suivant un traumatisme crânien non pénétrant, avec un score de Glasgow initial de 13, 14 ou 15. Comité SFMU/SFAR, avec SFBC, SFR, SOFMER ; format PICO, 3 champs (évaluation pré-hospitalière, prise en charge aux urgences, modalités de sortie), 11 questions.

Choix méthodologique explicite de la source : format RPP (Recommandation de Pratiques Professionnelles) plutôt que RFE, faute de niveau de preuve suffisant pour la méthode GRADE numérique — **aucune recommandation de ce document ne porte de grade « 1/2 »** ; toutes sont formulées « les experts proposent de faire / de ne pas faire ».

Résultats (résumé officiel) : 13 recommandations ; accord fort pour 100 % d'entre elles après deux tours de cotation. Pour une question (réversion des inhibiteurs des récepteurs P2Y₁₂), aucune recommandation n'a pu être formulée.

Tableau 1 — Définition du traumatisme crânien léger (OMS 2004)	
1. Une ou plusieurs manifestations	Confusion ou désorientation • Perte de conscience ≤ 30 min • Amnésie post-traumatique < 24h • et/ou autres anomalies neurologiques transitoires (signes focaux, crise d'épilepsie, lésion intracrânienne ne nécessitant pas d'intervention chirurgicale)
2. Score de Glasgow	13 à 15, 30 minutes après la blessure ou plus tard lors de la présentation aux soins

Traumatisme crânien léger de l'adulte

Champ 1 — Évaluation pré-hospitalière



Champ 1 — Évaluation pré-hospitalière

Réf.	Recommandation	Grade
R1	Les experts proposent que les patients victimes d'un traumatisme crânien léger, pour lesquels la régulation médicale est sollicitée, ne soient pas orientés de façon systématique vers une structure des urgences s'ils peuvent être surveillés par une tierce personne, en l'absence de : trouble de coagulation préexistant (dont traitement anticoagulant) ; âge > 65 ans ET traitement par antiplaquettaire(s) ; intoxication (médicamenteuse, alcool, autre) ; symptômes en dehors de céphalées (vomissement, perte de connaissance, amnésie > 30 min, convulsion, déficit focalisé, altération de la vigilance) ; signe de traumatisme (hématome en lunettes, embarrure, signes de fracture de la base du crâne, hématome mastoïdien).	AE

Facteurs prédictifs de lésion intracrânienne identifiés dans la littérature (hors contexte de régulation médicalisée) : altération de la vigilance (GCS<15) à la prise en charge ou à 2h, perte de connaissance, convulsions, déficit sensitivomoteur, vomissements itératifs, traumatisme ouvert avec embarrure, signes de fracture de la base du crâne, âge >65 ans (voire >60), amnésie antérograde. Patient <65 ans sous monothérapie antiplaquettaire, asymptomatique, sans autre facteur de risque : surveillance simple à domicile envisageable (incidence d'hémorragie intracrânienne modérément augmentée sous antiagrégation, mais sans augmentation du risque neurochirurgical ou de décès).

Traumatisme crânien léger de l'adulte

Champ 2 — Éléments cliniques & biomarqueurs



Champ 2 — Éléments cliniques à risque & biomarqueurs

Réf.	Recommandation	Grade
R2.1	Les experts proposent de stratifier le risque d'aggravation clinique ou de lésion intracrânienne selon la classification suivante — Risque élevé : troubles de l'hémostase (anticoagulants, bithérapie antiplaquettaire, maladie hémorragique congénitale) ; signes de fracture de la voûte ou de la base du crâne (Tableau 2) ; GCS < 15 à 2h du traumatisme sans intoxication ; plus d'un épisode de vomissements ; convulsions post-traumatiques ; déficit neurologique focalisé. Risque intermédiaire : âge ≥ 65 ans avec mono-antiagrégation plaquettaire ; GCS < 15 à 2h du traumatisme avec intoxication ; traumatisme à cinétique élevée (Tableau 3) ; amnésie des faits survenus plus de 30 min avant le traumatisme.	AE
R2.2.1	Les experts proposent de réaliser un dosage sanguin de la protéine S100B, lorsque celui-ci est disponible, dans les 3h suivant le traumatisme, chez les patients à risque intermédiaire (cf. R2.1) pour limiter le nombre de scanners cérébraux.	AE
R2.2.2	Les experts proposent de réaliser un dosage sanguin combinant UCH-L1 et GFAP, lorsque ceux-ci sont disponibles, dans les 12h suivant le traumatisme, chez les patients à risque intermédiaire (cf. R2.1) pour limiter le nombre de scanners cérébraux.	AE

Seule modification vs. les recommandations 2012 : la monothérapie par aspirine ou clopidogrel n'est plus considérée comme facteur de risque de lésion hémorragique. Prévalence des lésions intracérébrales sévères chez le TCL : 7,1 % (IC95 [6,8-7,4]) ; décès ou intervention neurochirurgicale : 0,9 % seulement (méta-analyse Easter et al.). Protéine S100B <0,1 µg/L dans les 3h : sensibilité 96,4-100 %, VPN 96,9-100 % pour éliminer une lésion significative. Dosage combiné UCH-L1 (seuil 327 pg/mL) + GFAP (seuil 22 pg/mL) dans les 12h : spécificité 36,7 %, sensibilité 97,3 %, VPN 99,5 %.

Tableau 2 — Signes évocateurs d'une fracture	Détail
Base du crâne	Otorrhée ou rhinorrhée, ecchymose mastoïdienne, ecchymose périorbitaire, hémotympan ou saignement extériorisé par le conduit auditif
Voûte du crâne	Discontinuité palpable de la voûte, suspicion d'embarrure ouverte ou fermée du crâne

Tableau 3 — Éléments évocateurs d'une cinétique élevée : occupant éjecté du véhicule • véhicule retourné • piéton ou cycliste renversé et sans casque • chute d'une hauteur > 5 marches ou > 2 m.
--

Traumatisme crânien léger de l'adulte

Champ 2 — Délai TDM & Doppler transcrânien



Champ 2 — Délai de la TDM & Doppler transcrânien

Réf.	Recommandation	Grade
R2.4	Les experts proposent de réaliser une TDM cérébrale le plus précocement possible pour identifier les lésions intracrâniennes significatives, chez les patients présentant un TCL : idéalement dans l'heure suivant l'admission pour les patients à risque élevé d'aggravation clinique ou de lésion intracrânienne ; au plus tard dans les 8 heures pour les patients à risque intermédiaire.	AE
R2.3	Les experts proposent de réaliser, après un scanner cérébral anormal, un Doppler Transcrânien chez les patients traumatisés crâniens légers pour évaluer le risque d'aggravation neurologique précoce.	AE

Numérotation source conservée telle quelle : R2.4 (délai de la TDM) est littéralement imprimé sous la Question 2.3, et R2.3 (Doppler transcrânien) est littéralement imprimé sous la Question 2.4 dans le document source — un intervertissement de numérotation propre à la source elle-même, reproduit fidèlement ici sans correction.

Délai de 8h retenu sur la base des études de validation des règles internationales (CCHR, New Orleans, NICE), ayant montré qu'un délai de 8h permet d'identifier les lésions chez la quasi-totalité des patients des cohortes. Scanner avec injection si signes de dissection carotidienne : fracture du rachis cervical, déficit neurologique non expliqué par l'imagerie, syndrome de Claude Bernard Horner, fracture de Lefort II/III, fracture de la base du crâne, traumatisme des tissus mous cervicaux. Doppler transcrânien : seuils index de pulsatilité <1,25 et vitesse diastolique >25 cm/s associés à l'absence d'aggravation précoce — VPN 98 % (IC95 [96-100]) globalement, 100 % pour le TCL spécifiquement (356 patients, GCS 9-15), réalisé après le scanner sans injection, au maximum dans les 12h.

Traumatisme crânien léger de l'adulte

Champ 2 — Imagerie de contrôle & anticoagulants



Champ 2 — Imagerie de contrôle & réversion des anticoagulants

Réf.	Recommandation	Grade
R2.5	Les experts proposent de ne pas réaliser d'imagerie de contrôle aux patients présentant une lésion intracrânienne sur la TDM initiale, en dehors des situations suivantes : aggravation neurologique ; patient âgé de plus de 65 ans ; troubles de l'hémostase, en dehors de la prise d'aspirine seule.	AE
R2.6.1	Les experts proposent de réaliser une réversion immédiate des anti-vitamine K chez les patients présentant une lésion hémorragique intracrânienne objectivée par une imagerie après un TCL, pour limiter le risque d'aggravation neurologique.	AE
R2.6.2	Les experts proposent de réaliser une réversion immédiate des anticoagulants oraux directs chez les patients présentant une lésion hémorragique intracrânienne objectivée par une imagerie après un TCL, pour limiter le risque d'aggravation neurologique.	AE
R2.6.3	Les experts proposent de discuter la conduite à tenir de façon collégiale chez les patients porteurs d'une valve cardiaque mécanique.	AE

Un INR >3 à la prise en charge est associé à un risque plus élevé de saignement retardé (RR=14 IC95 [4-49]). Modalités de réversion proposées : AVK — CCP non activé 25 UI/kg + vitamine K 10 mg IV ou PO ; apixaban ou rivaroxaban — CCP 50 UI/kg (max 5000 UI, pas d'antidote spécifique disponible) ; dabigatran — idarucizumab 5 g IV (ou CCP 50 UI/kg IV si indisponible). 5 % des TCL avec GCS 15 ont une imagerie anormale (30 % si GCS 13-15), dont 1 % nécessitent une prise en charge neurochirurgicale — un contrôle scanographique après 48h (en l'absence d'aggravation clinique) peut raisonnablement être proposé.

Traumatisme crânien léger de l'adulte

Champ 2 — Antiplaquettaires & retour à domicile



Champ 2 — Antiplaquettaires & retour à domicile

Réf.	Recommandation	Grade
R2.7	Les experts proposent de ne pas neutraliser l'aspirine chez un patient traité par aspirine avec lésion hémorragique intracrânienne après un TCL, pour limiter le risque d'aggravation neurologique.	AE

Absence de recommandation — les experts ne sont pas en mesure d'émettre une recommandation concernant la prise en charge spécifique des patients traités par un inhibiteur des récepteurs P2Y₁₂ (clopidogrel, prasugrel, ticagrelor) présentant une lésion hémorragique intracrânienne après un TCL, faute de données suffisantes.

Réf.	Recommandation	Grade
R2.8	Les experts proposent d'autoriser un retour à domicile des patients depuis la structure des urgences, même en présence d'anticoagulants ou d'agents antiplaquettaires, si au moins un de ces éléments est présent : patient à faible risque de saignement (cf. R2.1) ; dosage d'un biomarqueur sérique négatif ; TDM initiale ne retrouvant pas de saignement.	AE

Transfusion plaquettaire sous aspirine : sans bénéfice démontré sur l'expansion de l'hématome, le recours neurochirurgical ou la mortalité (méta-analyse Alvikas — OR=0,88 [0,34-2,28] pour la progression hémorragique). Sous clopidogrel, le risque de resaignement et de recours chirurgical est augmenté ; des données préliminaires suggèrent un possible bénéfice de la transfusion plaquettaire, insuffisantes à ce jour pour recommander. Retour à domicile : éléments cliniques requis — absence d'intoxication associée, absence de vomissements itératifs, absence de céphalées importantes persistantes, GCS à 15, absence de déficit neurologique, absence d'autre motif d'hospitalisation.

Traumatisme crânien léger de l'adulte

Champ 3 — Filière de soins & information de sortie



Champ 3 — Filière de soins & information de sortie

Réf.	Recommandation	Grade
R3.1	Les experts proposent que la persistance de symptômes jugés invalidants par le patient au-delà de 7 jours après le traumatisme doive amener à une évaluation médicale.	AE
R3.2	Les experts proposent que les patients présentant un TCL traité en ambulatoire, et le cas échéant leur entourage, bénéficient d'une information éclairée écrite et orale standardisée sur les motifs devant amener à reconsulter aux urgences dans les 48 heures suivant le retour à domicile.	AE

Des plaintes cognitives chroniques (>3 mois) sont présentes au décours de 50 % des TCL, invalidantes et sévères dans 10 % des cas — moins d'un patient sur 2 reçoit une information adaptée aux urgences, moins d'un sur 2 bénéficie d'un suivi à 3 mois (étude américaine). Suivi actif requis en cas de symptômes marqués initialement et/ou persistants >7 jours (ambulatoire si simple, équipes spécialisées si forte complexité ou séquelles >4-6 semaines) : vertiges, troubles du sommeil, troubles de la vue, fatigue persistants. Signes rassurants ne nécessitant pas de suivi actif : faibles symptômes s'amendant en <24-48h.

Annexe 2 (source) — Fiche d'information de sortie

Signes devant amener à consulter en urgence (SAMU 15) dans les 48h suivant la sortie : perte de connaissance, somnolence excessive ou baisse de la vigilance • trouble du comportement ou convulsions • trouble de la vision, de l'audition ou de la parole • trouble de l'équilibre • difficulté à mobiliser un membre • maux de tête intenses ou résistants aux antalgiques • vomissements ou nausées • écoulement par le nez ou les oreilles • douleurs cervicales.

Symptômes fréquents pouvant persister, devant disparaître dans les 7 jours : mal de tête modéré, nausées sans vomissement, vertiges, difficultés de concentration ou de mémoire, troubles du sommeil ou fatigue, manque d'appétit — en cas de doute ou de persistance au-delà de 7 jours, consulter le médecin traitant.

Éviter toute prise médicamenteuse sans avis médical. En cas de pratique d'une activité ou d'un sport à risque de nouveau traumatisme crânien, ne pas reprendre cette activité dans les 15 jours.

Traumatisme crânien léger de l'adulte

Synthèse, sources & traçabilité



Synthèse et messages clés

- Régulation médicale : orientation systématique vers les urgences non requise si surveillance possible par un tiers et absence de trouble de coagulation, âge > 65 ans + antiplaquettaire, intoxication, symptôme autre que céphalée, ou signe de traumatisme.
- Stratification du risque (élevé vs intermédiaire) dès l'admission — biomarqueurs (S100B < 3h, ou UCH-L1 + GFAP < 12h) utilisables chez les patients à risque intermédiaire pour limiter le recours au scanner.
- TDM : idéalement < 1h si risque élevé, au plus tard < 8h si risque intermédiaire. Doppler transcrânien après scanner anormal pour évaluer le risque d'aggravation précoce.
- Pas de contrôle scanographique systématique après lésion initiale (sauf aggravation, âge > 65 ans, ou trouble de l'hémostase hors aspirine seule). Réversion immédiate des AVK et des AOD si lésion hémorragique objectivée ; discussion collégiale si valve mécanique ; pas de neutralisation de l'aspirine seule ; aucune recommandation possible pour les inhibiteurs P2Y12 (clopidogrel/prasugrel/ticagrelor), faute de données.
- Retour à domicile possible (y compris sous anticoagulant/antiplaquettaire) si faible risque de saignement, biomarqueur négatif, ou TDM initiale sans saignement.
- Sortie : information écrite et orale standardisée systématique (fiche patient), surveillance active des signes d'alerte sur 48h ; évaluation médicale si symptômes invalidants persistant > 7 jours, avec accès à une filière de soins spécialisée si besoin.

Sources et traçabilité

Document source : « Prise en charge des patients présentant un traumatisme crânien léger de l'adulte » — Recommandations de Pratiques Professionnelles de la SFMU, en association avec la SFAR, avec SFBC, SFR, SOFMER. 2022, texte validé par la Commission des Référentiels de la SFMU (19/05/2022), le CA SFMU (24/05/2022), le Comité des Référentiels Cliniques de la SFAR (03/09/2022), le CA SFAR (15/09/2022). Comité de 22 experts, coordination C. Gil-Jardiné (SFMU), J.F. Payen (SFAR).

Méthodologie : format RPP (et non RFE), choix explicite de la source faute de niveau de preuve suffisant pour la méthode GRADE numérique — toutes les recommandations portent le tag littéral unique « Avis d'experts (Accord Fort) », cité ici tel quel (« AE »). Numérotation R2.3/R2.4 intervertie dans la source elle-même (cf. encart Champ 2), conservée fidèlement.

Couverture : 14 énoncés individuellement formulés selon le cadre PICO propre du texte (R1, R2.1, R2.2.1-2, R2.3, R2.4, R2.5, R2.6.1-3, R2.7, R2.8, R3.1, R3.2) reproduits intégralement, ainsi que l'absence de recommandation (P2Y12) et l'Annexe 2 (fiche d'information de sortie). Le résumé officiel de la source annonce un total agrégé de « 13 recommandations » — chiffre cité tel quel dans l'introduction sans être recalculé, la source ne détaillant pas la correspondance exacte avec le découpage par énoncé individuel. L'Annexe 1 (comparatif dense de 7 scores cliniques internationaux) n'est pas reproduite intégralement (tableau multi-colonnes à l'extraction disloquée) — les scores les mieux validés (CCHR, NOC, CHIP) sont cités dans l'argumentaire de R2.1 ; se référer au texte intégral pour le comparatif complet.

Avertissement : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Il reprend l'intégralité des recommandations de la RPP mais ne remplace pas le texte intégral et n'est ni édité ni validé par la SFMU/SFAR. En cas de doute, se référer au texte intégral, aux recommandations ultérieures et/ou à un avis spécialisé.